

Bez wagi — bez zmiany — *refeeding* jako warunek terapii

CBT-E u głodnego mózgu jest ograniczona. Restauracja wagi do BMI ≥ 19 –20 (dorośli) jest warunkiem trwałej zmiany. Współpraca z dietetykiem ED obowiązkowa.

CZAS: proces 6–12 miesięcy + 6 mies. konsolidacji

REALIZACJA: każdy AN z niedowagą (BMI < 18.5 dorośli; < 5 percentyla dzieci/młodzież)

ŹRÓDŁO: Garber i in. (2016, *J Eat Disord*); AED (2021, *Medical Care Standards*); Marzola i in. (2013, *BMC Psychiatry*); Mehler & Andersen (2017)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **cztery elementy** rehabilitacji: restauracja wagi, normalizacja jedzenia, powrót funkcji biologicznych, odzyskanie sygnałów głodu i sytości. Sekcja 02 — **dziesięć kroków** protokołu klinicznego. Sekcja 03 — **karta startowa** do wypełnienia z pacjentem i dietetykiem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Rehabilitacja żywieniowa (ang. *nutritional rehabilitation*) *nie jest „opcją obok terapii”* — jest warunkiem jej skuteczności. Głodny mózg (Minnesota Study, Keys i in., 1950) ma ograniczoną plastyczność — CBT-E poznawcza pracuje wtedy na pustym silniku. Cel: zdrowa waga (orientacyjnie BMI ≥ 19 –20 u dorosłych, 50. percentyl u młodzieży) i pełna funkcja biologiczna. Tempo: 0.3–0.5 kg/tydz. ambulatoryjnie. Współpraca z dietetykiem ED i lekarzem jest obowiązkowa — psychoterapeuta sam *nie* prowadzi rehabilitacji.

01 Cztery elementy rehabilitacji — co dokładnie przywracamy

ELEMENT	CO KONKRETNIE I JAK DŁUGO
1 · Restauracja wagi	Osiągnięcie zdrowej masy ciała. <i>Orientacja:</i> BMI ≥ 19 –20 dorośli, 50. percentyl dzieci/młodzież, <i>lub</i> waga, na której powraca pełna funkcja biologiczna (miesiączka, libido, energia). Tempo: 0.3–0.5 kg/tydz. ambulatoryjnie; 0.5–1 kg/tydz. szpitalnie.
2 · Normalizacja jedzenia	Elastyczne, nieurytualizowane, zróżnicowane jedzenie. <i>Wszystkie grupy:</i> węglowodany, białko, tłuszcze, warzywa, owoce, nabiał. <i>Żadne</i> nie są wykluczone. Wprowadzanie hierarchiczne (zob. fear foods).
3 · Przywrócenie funkcji biologicznych	Miesiączka u kobiet, libido, energia, koncentracja, sen, gęstość kości. <i>Marker</i> osiągnięcia zdrowej wagi: powrót miesiączki (zwykle 3–6 mies. po wadze 90% historycznej). Pełen powrót gęstości kości — 12–18 miesięcy.
4 · Powrót sygnałów głodu/sytości	Peptydy regulacyjne (ghrelina, leptyna, CCK) odbudowują się <i>powoli</i> — 6–18 miesięcy <i>po</i> restauracji wagi. Pacjent w międzyczasie je z <i>planu</i> , nie „z głodu”.

Bez wagi — bez zmiany. Klinicysta, który stosuje tylko CBT poznawczą u pacjenta z BMI 16, pracuje na pustym silniku. Mózg w głodzie ma ograniczoną plastyczność. Restauracja wagi = warunek terapii, nie „opcja”.

02 ☉ Dziesięć kroków protokołu (Garber 2016; AED 2021)

1. **Ocena startowa** — aktualna waga, BMI, tempo spadku, objawy somatyczne (bradykardia, hipotensja, hipotermia), badania labowe (elektrolity, fosforany, EKG). Koordynacja z lekarzem i dietetykiem przed startem.
2. **Ustalenie celu** — „zdrowa waga” = waga, na której wraca pełna funkcja biologiczna. *Orientacja:* BMI 19–21. *Nie* dyskutuj z pacjentem o „docelowej wadze” w liczbach — to wyzwalacz. Komunikat: „*Celem jest, żeby Twoje ciało wróciło do pełnej funkcji. Zobaczmy, na jakiej wadze to się stanie*”.
3. **Plan energetyczny — przez dietetyka ED** — w koordynacji z dietetykiem specjalistycznym (nie „fitness dietetykiem”). Konkretnie wartości *nie* są ustalane przez psychoterapeutę. To jest *nadmiar* względem utrzymania, prowadzony stopniowo z monitorowaniem refeeding.
4. **Struktura posiłków** — 3 posiłki + 2–3 przekąski, *wszystkie* grupy pokarmowe (węglowodany, białko, tłuszcze, warzywa, owoce, nabiał). *Żadne* nie są wykluczone. Wprowadzanie fear foods hierarchicznie.
5. **Tempo przyrostu wagi** — 0.3–0.5 kg/tydz. ambulatoryjnie. Za wolne (<0.3) — zwiększyć podaż. Za szybko (>1.0) — sprawdź obrzęki (refeeding) lub ukrytą kompensację.
6. **Ważenie** — raz w tygodniu, u lekarza/dietetyka, *nie* w domu. Codzienny dostęp do wagi w domu = uzależnienie. Warunki jednolite: rano, po toalecie, w lekkiej odzieży.
7. **Wsparcie psychologiczne** — przyrost wagi jest *emocjonalnie* ciężki. Pacjent czuje obrzęki, lęk, wstyd. Normalizuj: „*To normalne — pierwsze 3–5 kg to woda, nie tłuszcz. Obrzęki znikną za 2–4 tyg.*” *Nie* minimalizuj cierpienia.
8. **Stagnacja wagi (ang. plateau)** — czasem waga „zatrzymuje się”. Przyczyny: niedostateczna podaż, ukryta kompensacja, adaptacja metaboliczna (rzadko). Rozwiązanie: dietetyk zwiększa podaż.
9. **Powrót miesiączki** — marker osiągnięcia zdrowej wagi u kobiet. Zwykle 3–6 mies. po osiągnięciu wagi 90% historycznej. Brak miesiączki mimo „zdrowej wagi” = waga docelowa jest wyższa, jeszcze nie osiągnięta.
10. **Faza konsolidacji** — po osiągnięciu zdrowej wagi — 6 miesięcy utrzymania. Waga zwykle „osadza się” na pewnym poziomie. *Nie* spieszyć się z redukcją podaży.

03 Karta startowa — do wypełnienia z dietetykiem ED

AKTUALNA WAGA, WZROST, BMI

— pomiar u lekarza/dietetyka, *nie samodzielnie*; data pomiaru

NAJNIŻSZA HISTORYCZNA WAGA I OBECNA ŚCIEŻKA

— spadek/stabilizacja/wzrost; tempo spadku w ostatnich 6 mies.

FUNKCJE BIOLOGICZNE — KTÓRE OBECNE, KTÓRE NIEOBECNE

— miesiączka (data ostatniej), libido, sen, energia, koncentracja, gęstość kości (DEXA, jeśli wykonano)

ZESPÓŁ OPIEKI — KTO, JAKIE KONTAKTY

— lekarz prowadzący, dietetyk ED, psychoterapeuta; ustalone terminy wizyt

CEL TYGODNIOWY PRZYROSTU WAGI

— 0.3–0.5 kg/tydz. ambulatoryjnie; ustala dietetyk/lekarz

Klucz: rehabilitacja żywieniowa jest *poważnym* procesem medycznym — *nie* może być prowadzona „na oko” przez psychoterapeutę samego. Współpraca z dietetykiem specjalistycznym ED (nie „fitness dietetykiem”) jest *konieczna*. Jeśli dietetyk nie jest dostępny w systemie — pomyśl o kilku konsultacjach płatnych lub korzystaniu z protokołu AED (2021). Błąd „improwizacji” może skutkować ciężkim niedożywieniem lub refeeding syndrome. **Komunikat dla pacjenta:** „*nie chcę, żeby przyrost wagi był dla Ciebie chaosem. Zespół (lekarz + dietetyk + ja) jest po to, żeby ten proces był bezpieczny — fizycznie i psychicznie*”.

⚠ **Refeeding syndrome:** u pacjenta z BMI <14, długą restrykcją lub ciężką niedożywnością wprowadzanie pełnej podaży wymaga ścisłej kontroli medycznej (fosforany, potas, magnez, tiamina, EKG) przez pierwsze 1–2 tyg. Patrz karta refeeding syndrome. Bez tej kontroli — rzeczywiste ryzyko arytmii i niewydolności krążenia. Hospitalizacja lub PHP jest standardem dla ciężkich przypadków, *nie „opcją*”.